

La main postérieure est légèrement plus bas que la main antérieure qui est légèrement plus haut. Parce que mon poumon fait ce mouvement de bascule sur son axe. Il fait un mouvement comme ça et il fait un mouvement comme ça. Mais en même temps, je me mets dans son champ embryonnaire. Donc je recherche son point de fulcrum embryonnaire. Son point de fulcrum embryonnaire, c'est ce champ d'aspiration. Donc je cherche d'aller dans ce mouvement pour aller me repotentialiser dans sa fonction primaire. C'est-à-dire d'être prêt à pouvoir prendre le souffle d'avis. Tout le développement des neuf mois du développement embryonnaire le prépare à ce premier mouvement. Vous savez ce que les poumons vont fabriquer dans le stade embryonnaire ? Du liquide amniotique. Que les poumons vont reprendre une fonction de fabrication liquide amniotique qui est très importante. Parce que l'embryon, il est constellé et il boit ce liquide. C'est comme une grande communication autocrine. Je m'informe aussi de mes reins. Une partie de ce liquide amniotique de la poche des os sera aussi de l'urine. Là, il va y avoir ce qu'on appelle une protéine spécifique qu'on appelle le surfactant. Qui va être fabriqué un peu plus tard. Va permettre l'ouverture de tes poumons au moment de la naissance. Au départ, ma pression est assez douce. Je dois aller juste pour moi retrouver petit à petit cette bulle où le poumon peut s'organiser. Je lui redonne simplement un espace d'organisation et de liberté. ...pulmonaire, entre la plaie viscérale et la plaie pariétale, j'ai cette rencontre entre ma trachée, ma bronche et cette magnifique rencontre entre un tissu bronchique aérien qui contient de l'air, qui contient un volume résiduel et à côté, j'ai tout cet espace liquidien, voilà, il y a une petite fréquence. Là, on rentre dans un tissu où il a protégé une vieille tristesse, il a trouvé un échappatoire, il veut m'amener dessus donc je vais quand même aller tout doucement. Et là, si on va, le tissu peut commencer à me parler. C'est un dialogue pour le moment qu'on est ensemble. On y va dans la

discrétion. On commence à avoir un échange maintenant oxydatif tissulaire. Je ne suis pas encore dans la profondeur. Je suis encore dans la superficie. Ah voilà, je passe, il vient de me montrer que je peux aller par la grande cissure postérieure pour aller vers cet espace, voilà. Il m'a montré une porte, je peux commencer tout doucement à descendre. N'oubliez pas que c'est une zone où on a caché nos tristesses. Un enfant qui pleure dans ses poumons, un enfant qui fait des bronchites ou des tours et répétitions. Parfois quand tu fais une pneumonie ou une bronchite, tu as la tristesse qui est intériorisée et c'est une façon de l'extérioriser. Parce que tu ne sais pas pleurer, voilà, hop, là je suis sur un autre niveau. Là, je laisse le corps travailler. Tu es vraiment sur un axe là. Oui, voilà. Tout à l'heure, c'était plutôt pour moi du liquidien, des vasculaires. Et là maintenant, je suis sur cet axe. Tu es sur un axe là. Merci, on a un excellent. Là le corps il cherche, il va simplement, c'est-à-dire qu'il peut se réorganiser. On peut commencer à libérer des choses, si tu connais, et puis tu peux faire un voyage, parfois parce que tu rentres dans un tissu somatopleural qui est une continuité tissulaire. Ça peut aller t'indiquer la symbolique du corps. Les récessus costopleuropulmonaires, qui sont des sacs d'accumulation d'exudats transpleural, transpiritonéal, donc ce sont des lieux où les déchets du poumon viennent se déposer. Ce sont des lieux de moindre mobilité, il faut les dynamiser, il faut les libérer. Il y a des petits trous ici qui accumulaient ces espaces, donc cet exudat, c'est-à-dire du liquide collant, muqueux, glaireux, lymphatique. Aussi n'oubliez pas l'importance de ce poumon qui est suspendu, donc d'apprendre à bien dégager le poumon par rapport à ses propres... points d'attache, vertébraux, transversaux, costopleural, ce qu'on appelle les ligaments suspenseurs du dôme pleural. Vous avez ce qu'on appelle ces récessus, qu'on appelle les récessus costodiafragmatiques, mais il y a encore un récessus important qu'on appelle le récessus frémomédiastinal, qui est en rapport avec le cœur

ici, tu vois. Cette zone ici, et ce poumon, c'est un récessus important pour la liberté de mon médiastin, la liberté du cœur. Là on a le île pulmonaire, qui est vraiment tout ce point de relation avec son fulcrum embryonnaire. N'oubliez pas que ces lignes rentrent ici dans ces espaces avec l'importance de ce diaphragme. La production du liquide amniotique, on voit qu'elle se développe, tu vois, à partir déjà de la cinquième semaine, et de façon très importante jusqu'au niveau de la 38e semaine, et on voit l'apparition déjà du surfactant. Le surfactant qui commence à se développer aux environs de la 25e semaine pour être parfaitement adéquat au niveau de la 38e. C'est une période importante de liquide amniotique qui est fabriquée comme source de liquide amniotique. Donc tout ce qui est pathologie de type pulmonaire, bronchite, bronchiolite, etc. peuvent être des manifestations qui cherchent à résoudre des problèmes, dans le stade embryonnaire, sous forme d'un état non dit, qui s'exprime comme un pleur, comme un liquide. On pleure dans les poumons.